Neurodivergencia: cuántas personas somos y qué falta por conocer

FAND · Alianza para la Neurodivergencia
Parte 1. Una lectura sencilla de los estudios sobre población.
Información revisada el 7 de octubre de 2026.

¿Para qué hemos preparado este informe?

Queremos entender cuántas personas neurodivergentes hay, qué conocemos de cada perfil y quiénes siguen poco presentes en los estudios. Encontrar buenas cifras ayuda a hacer visibles necesidades que a menudo pasan desapercibidas.

Los estudios proceden de distintos países y épocas. Por eso, junto a cada cifra indicamos de dónde viene, a quiénes se estudió y de qué año son los datos. Cuando una investigación reúne trabajos de varios países, lo señalamos como una revisión internacional.

De dónde sale la información

Hemos reunido investigaciones científicas, datos de organismos públicos y una estimación de Autismo España. Las fuentes están numeradas y puedes consultarlas al final. En algunos casos hemos podido leer el resumen del estudio, pero no todo el artículo.

Este documento explica investigaciones ya publicadas. FAND no ha realizado un censo propio ni ha recogido estos datos directamente. La búsqueda puede dejar fuera otros trabajos; el documento tampoco ha sido revisado todavía por un comité profesional de FAND.

Cinco palabras que aparecen en los estudios

• **Prevalencia:** cuántas personas presentan un perfil dentro de un grupo; suele expresarse como porcentaje.

• **Diagnósticos registrados:** personas que aparecen identificadas en un sistema sanitario o una encuesta.

• **Información declarada:** lo que cuentan las personas que responden a una encuesta.

• **Cribado:** preguntas que ayudan a detectar señales para explorar con un profesional; no dan un diagnóstico por sí solas.

• **Infradiagnóstico:** personas que podrían tener un perfil pero todavía no han sido identificadas. Los estudios pueden intentar calcular cuántas son.

Una persona puede tener varios perfiles. Por ejemplo, autismo y TDAH. Si sumamos las cifras de ambos, podríamos contarla dos veces.

1. Qué cifras han encontrado los estudios

Perfil	Qué se encontró	De dónde viene y a quién incluye
Autismo	Unos 61,8 millones de personas; el cálculo puede situarse entre 52,1 y 72,7 millones. [1,2]	Estimación mundial para 2021, todas las edades. Publicada en 2025.
TDAH en adultos, desde la infancia	Unos 139,84 millones; aproximadamente el 2,58% de adultos. [3]	Revisión internacional publicada en 2021, con estimación para 2020.
Síntomas de TDAH en adultos	Unos 366,33 millones; el 6,76%. [3]	La misma revisión, usando una definición más amplia: no exige comprobar inicio infantil. Son síntomas, no diagnósticos confirmados.
Dislexia	Alrededor del 7,10% de escolares de primaria. [4]	Revisión de estudios de distintos países, publicada en 2022.
Dispraxia / trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC)	Alrededor del 5% de niños y niñas. [5]	Revisión internacional publicada en 2024. Los resultados varían entre estudios.
Discapacidad intelectual	Unas 10 personas por cada 1.000 (1,04%). [6]	Revisión internacional de 2011 con 52 estudios de 1980-2009. Es una referencia antigua.
Trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL)	El 7,58%; el margen calculado fue del 5,33 al 10,66%. [26]	Estudio escolar de Inglaterra, publicado en 2016, sobre dificultades del lenguaje sin una causa conocida.
Tourette en adultos	Una revisión de 2012 calculó 0,05%; otra de 2019, 118 personas por millón. [7,8]	Revisiones de estudios anteriores. Había pocos trabajos y los cálculos son diferentes.

Por qué algunas cifras son tan distintas

Depende de cómo se busca el perfil, qué preguntas se hacen y qué edades se incluyen. En el TDAH adulto, por ejemplo, estudiar síntomas actuales no es lo mismo que comprobar también que comenzaron en la infancia. [3]

Los porcentajes de esta tabla describen grupos concretos. Las investigaciones escolares nos hablan de niños y niñas; todavía necesitamos mejores datos para seguir su realidad a lo largo de toda la vida.

2. Qué conocemos en distintos países

Cada país recoge información de una manera. Esta tabla muestra los datos que hemos localizado y explica cómo se obtuvieron.

País	Qué sabemos	Cómo se recogió
España	Autismo España estima alrededor de 500.000 personas autistas. [9]	Estimación asociativa basada en una referencia del 1% de la población.
Inglaterra	Para 2018: unas 463.500 personas con diagnóstico y entre 435.700 y 1.197.300 que podrían estar sin identificar. [10]	Estudio publicado en 2023: combina datos registrados y cálculos.
Estados Unidos	Unos 5,44 millones de adultos autistas, estimación para 2017. En 2023, 15,5 millones de adultos declaraban diagnóstico de TDAH. [11,12]	Autismo: cálculo estadístico. TDAH: encuesta.
Brasil	2,4 millones de personas declaraban diagnóstico de autismo en el censo de 2022. [13]	Preguntas a una muestra de la población del censo.
Australia	290.900 personas declaraban autismo en 2022. [14]	Encuesta oficial.
Países Bajos	Unos 280.000 hombres y 140.000 mujeres desde los 4 años declaraban autismo en 2022-2024. [15]	Encuesta; las cifras publicadas están redondeadas.
Francia	119.260 personas identificadas en datos sanitarios de 2017. [16]	Se usaba la categoría histórica TED, trastornos generalizados del desarrollo.
Italia	Un niño o niña de cada 77 entre los 7 y los 9 años. [17]	Dato sobre autismo difundido por el Instituto Superior de Sanidad en 2022.
Canadá	El 2% de niños y jóvenes de 1-17 años declaraba diagnóstico de autismo en 2019. [18]	Encuesta recogida en el marco oficial sobre autismo de 2024.
Suecia	En 2023, casi el 5% de hombres y el 4% de mujeres de 18-24 años tenía diagnóstico de autismo. [19]	Registro sanitario por edad y sexo.

Estas cifras pueden dejar fuera a personas sin diagnóstico. Un sistema que identifica menos casos no demuestra, por sí solo, que haya menos personas neurodivergentes.

3. Personas sin diagnóstico: qué sabemos

Sospechar, responder a un cuestionario y tener diagnóstico

Algunas personas se reconocen en experiencias de neurodivergencia y empiezan a hacerse preguntas. Otras obtienen señales en un cuestionario. También puede haber personas que nunca lo hayan sospechado. Los estudios no siempre cuentan estas situaciones por separado.

Inglaterra: un cálculo sobre autismo sin identificar

Un estudio publicado en 2023 calculó que, en Inglaterra, entre 435.700 y 1.197.300 personas autistas podían estar sin diagnóstico en 2018. Entre las mayores de 20 años, el cálculo era de unas 404.000 a 1.081.500 personas. El punto medio se comunicó como alrededor de 750.000. [10]

El mismo trabajo estimó que solo entre el 3,5 y el 7,9% de las personas autistas de 50 años o más tendría diagnóstico, según las condiciones del cálculo. Es una señal de posible falta de identificación entre personas mayores. El grupo estudiado empieza a los 50 años. [10]

Inglaterra: personas pendientes de valoración

El servicio de salud de Inglaterra comunicó 294.792 pacientes con una solicitud de valoración por posible autismo abierta en junio de 2026. Esta cifra cuenta solicitudes en curso, no diagnósticos confirmados. Además, faltaban datos de un proveedor que había comunicado 22.900 pacientes en mayo. [20]

Estados Unidos: recibir el diagnóstico en la edad adulta

En una encuesta de 2023 de Estados Unidos, el 55,9% de los adultos que declaraban diagnóstico de TDAH lo había recibido ya en la edad adulta. El dato muestra diagnósticos tardíos, no cuántas personas siguen sin identificar. [12]

Qué nos falta en España

En esta búsqueda no hemos encontrado una encuesta que permita contar, para todos los perfiles y edades, cuántas personas tienen sospechas sin diagnóstico en España. Las encuestas de asociaciones y comunidades pueden ayudar a conocer experiencias, pero sus respuestas hablan de quienes participan.

Propuesta para FAND: escuchar por separado a personas con diagnóstico, con sospechas y pendientes de valoración. Así podremos conocer mejor sus experiencias sin confundir unas situaciones con otras.

4. Otros perfiles también se investigan

Lenguaje: escuchar a las personas adultas

Un estudio internacional publicado en 2026 reunió a 92 adultos que participaban en una base de investigación sobre TDL. De ellos, 30 declaraban diagnóstico y 62 mostraban señales en un cuestionario sin tener diagnóstico formal. El trabajo describe a ese grupo y recuerda que la investigación y los servicios siguen muy centrados en la infancia. [27]

Escritura: conocer mejor la disgrafía

Una revisión internacional de 2022 reunió 77 estudios sobre disgrafía, publicados entre 2015 y mayo de 2021. Encontró poca diversidad entre los participantes y una producción de estudios limitada. Sí existe investigación: lo que falta es conocer mejor a grupos y edades menos estudiados. [28]

Una revisión de 2024 sobre escritura en niños con TDAH señala otra dificultad: no todos los investigadores definen la disgrafía de la misma forma. Eso complica calcular cuántas personas la presentan. [29]

Coordinación: más conocimiento sobre adultos

Una revisión de 2026 estudió cuestionarios para detectar dificultades de coordinación en adultos. Encontró que todavía falta evidencia para usarlos como única herramienta de valoración. Investigar cómo se identifica un perfil es importante, aunque ese tipo de estudio no cuente a toda la población. [30]

Perfiles para los que aquí faltan cifras completas

Perfil	Qué falta por conocer en esta revisión
Discalculia	Una cifra que reúna diferentes países y todas las edades.
Disortografía	Un recuento propio: a veces se estudia junto a lectura y escritura.
Otros trastornos de tics	Datos separados de Tourette, porque no son el mismo grupo.
Altas capacidades	Cifras con una explicación clara de cómo se identificaron.
Doble o múltiple excepcionalidad	Cuántas personas reúnen altas capacidades y uno o varios perfiles.
Diferencias de procesamiento sensorial y otros perfiles	Datos con criterios claros sobre qué experiencias o condiciones se cuentan.

Que no tengamos aquí una cifra completa no significa que no existan estudios. El término neurodivergencia también puede incluir perfiles distintos según quién lo utilice.

5. La tercera edad también cuenta

Autismo: se está investigando más, pero aún falta

Una revisión internacional publicada en 2025 sobre memoria, pensamiento y cerebro en personas autistas señaló que 25 de los estudios incluidos contaban con participantes mayores de 65 años. También encontró pocos trabajos que siguieran a las mismas personas durante años y poca participación de quienes necesitan más apoyo. La búsqueda llegaba a enero de 2024. [21]

Otra revisión internacional, publicada en septiembre de 2026, encontró dificultades específicas, pero no una prueba de que todas las personas autistas envejezcan más rápido de la misma manera. [22]

Una revisión publicada el 30 de septiembre de 2026 reunió 15 estudios de personas de 50 años o más. Las personas autistas contaban mayores dificultades de memoria y pensamiento, aunque las pruebas no siempre reflejaban diferencias grandes. Los autores señalan que seguían participando pocas personas mayores de 65 años y que los trabajos incluidos no seguían su evolución durante años. [23]

TDAH: la investigación no debe quedarse en la infancia

Una revisión internacional publicada en línea en 2025 y en una edición de 2026 reunió diez estudios sobre memoria, atención y otras capacidades en personas con TDAH desde los 50 años. Tres siguieron a participantes a lo largo del tiempo y siete estudiaron su situación en un momento concreto. Sigue siendo poca información para conocer bien esta etapa. [24]

Una revisión internacional de 2020 obtuvo cifras diferentes según cómo se buscaba el TDAH: 2,18% en evaluaciones de investigación, 0,23% en diagnósticos clínicos y 0,09% en datos de tratamiento. Cada cifra reúne estudios distintos; su diferencia muestra cuánto influye la forma de recoger información. [25]

Qué sería importante estudiar mejor

• Personas de 65-74, 75-84 y 85 años o más, con distintas necesidades de apoyo.

• Cómo cambian la memoria, la atención y la autonomía con los años.

• Acceso a valoración, cuidados, vivienda, compañía y apoyo en el duelo.

• Dislexia, TDL, dispraxia, Tourette y otros perfiles en la tercera edad.

Estas son propuestas de FAND a partir de las lagunas encontradas. No son resultados de una nueva investigación.

6. Por qué todavía no podemos contar a todas en el mundo

Qué influye	Explicación sencilla
Cómo se define cada perfil	Si cambian las preguntas o los criterios, también puede cambiar a quién se cuenta. [3,29]
Cómo se recoge la información	Un registro sanitario cuenta personas identificadas; una encuesta recoge respuestas; un cuestionario busca señales. [25]
La edad	Muchos de los datos citados proceden de escolares. Las personas mayores siguen menos presentes en algunas investigaciones. [4,5,21,23]
Quién participa	Un grupo de voluntarios ayuda a conocer experiencias, pero puede ser distinto del resto de la población. [27]
El año	Publicar un estudio hoy no significa que sus datos sean de hoy.
Las combinaciones	Una persona puede tener varios perfiles. Sumarlos sin tenerlo en cuenta puede contarla más de una vez.

Qué nos dicen los estudios, en conjunto

Hay muchas personas neurodivergentes y todavía no conocemos bien a todas. Disponemos de cifras para algunos perfiles, países y edades, pero faltan datos para construir una imagen completa. Las personas sin identificar y las de mayor edad pueden quedar poco visibles.

En España, esta revisión no ha localizado una cifra que reúna todos los perfiles, todas las edades y todas las situaciones de diagnóstico. Los intervalos divulgativos del 10-20% no sustituyen ese recuento: calcular su punto medio, 15%, no lo convierte en un resultado científico.

Qué nos ayudaría a conocer mejor esta realidad

- Escuchar a grupos que reflejen la diversidad de la población.
- Preguntar por separado por diagnóstico, sospechas y valoraciones pendientes.
- Contar a cada persona una sola vez, aunque tenga varios perfiles.
- Incluir infancia, juventud, adultos y tercera edad.
- Explicar de dónde salen las cifras y actualizar los datos.

Son propuestas para mejorar la información. La falta de datos no significa ausencia de personas ni de necesidades.

Por qué necesitamos FAND

Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia. Y detrás de los datos que faltan también hay personas: quienes todavía no tienen diagnóstico, quienes no encuentran respuestas y quienes apenas aparecen en las investigaciones.

Conocer mejor cuántas personas neurodivergentes hay y qué necesitan puede ayudar a planificar apoyos, orientar recursos y hacer visibles realidades que siguen pasando desapercibidas. También necesitamos escuchar cómo viven, qué barreras encuentran y qué les ayudaría en su día a día.

Una asociación para escuchar, conectar y colaborar

Por eso estamos impulsando FAND · Alianza para la Neurodivergencia. Queremos acercar a personas, familias, profesionales y entidades para compartir conocimiento y apoyar una investigación que tenga en cuenta todos los perfiles y todas las etapas de la vida.

Nuestra intención es ayudar a detectar preguntas que siguen sin respuesta, facilitar la colaboración con equipos de investigación y promover que las personas neurodivergentes participen en la elección de los temas que se estudian. Para conocer esta realidad necesitamos investigaciones rigurosas y la experiencia de quienes la viven.

No queremos quedarnos solo en contar personas. Queremos que ese conocimiento contribuya a mejorar los apoyos, defender los derechos y construir entornos más accesibles e inclusivos.

Tu experiencia también cuenta

FAND está empezando. Cada persona que se acerca, comparte su experiencia o colabora puede ayudarnos a comprender mejor lo que falta y a construir una comunidad con más fuerza.

Sin las personas, FAND no sería posible.
Si quieres participar o colaborar, escríbenos por mensaje privado.

Tu experiencia cuenta. Tu voz hace falta.

¡Hazte FAND!

Bibliografía y fuentes

[1] GBD 2021 Autism Collaborators (2025). The global epidemiology and health burden of the autism spectrum.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39709974/

[2] OMS (2025). Autism.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

[3] Song et al. (2021). Global systematic review and meta-analysis of adult ADHD.
https://jogha.org/documents/2021/jogh-11-04009.htm

[4] Yang et al. (2022). Prevalence of developmental dyslexia in primary school children.
https://doi.org/10.3390/brainsci12020240

[5] Li et al. (2024). Prevalence of developmental coordination disorder in children.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39391054/

[6] Maulik et al. (2011). Prevalence of intellectual disability.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21236634/

[7] Knight et al. (2012). Prevalence of tic disorders.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22759682/

[8] Levine et al. (2019). Adulthood prevalence of Tourette syndrome.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584619302192

[9] Autismo España. Qué es el autismo: prevalencia.
https://autismo.org.es/el-autismo/que-es-el-autismo/

[10] O'Nions et al. (2023). Autism in England: assessing underdiagnosis.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37090088/

[11] Dietz et al. (2020). National and state estimates of adults with ASD, data 2017.
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/119183

[12] CDC (2024). ADHD diagnosis, treatment and telehealth use in adults, 2023.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7340a1.htm

[13] IBGE. Censo 2022: 2,4 millones de personas diagnosticadas con autismo.
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22700-censo-2022-contou-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil.html

[14] Australian Bureau of Statistics (2024). Autism in Australia, 2022.
https://www.abs.gov.au/articles/autism-australia-2022

[15] Statistics Netherlands (2025). Self-reported autism, 2022-2024.
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2025/14/3-percent-of-the-population-report-having-autism-spectrum-disorder

[16] Santé publique France. Autisme: données sanitaires de 2017.
https://www.santepubliquefrance.fr/autisme/donnees

[17] ISS (2022). Autismo: un bambino su 77 tra 7 e 9 anni.
https://www.iss.it/web/guest//comunicati-stampa/-/asset_publisher/fjTKmjJgSgdK/content/id/6875786

[18] Public Health Agency of Canada (2024). Framework for Autism in Canada.
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/framework-autism-canada.html

[19] Socialstyrelsen (2024). Autism - Förekomst och samsjuklighet.
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer/autism--forekomst-och-samsjuklighet-2024-11-9353/

[20] NHS England (2026). Autism Statistics, July 2025 to June 2026.
https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/autism-statistics/july-2025-to-june-2026

[21] Bessé et al. (2025). Cognitive and Cerebral Aging Research in Autism: A Systematic Review on an Emerging Topic. Autism Research, 18, 1122-1145.
https://doi.org/10.1002/aur.70031

[22] Dickinson, A., Ryan, D., Carroll, J. E. y Lord, C. (2026). Aging in autism: A systematic review of cognitive, neural, and physical health findings. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 188, 106820.
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2026.106820

[23] Gray, L., Hall, E., Hearne, B., Zhang, Y., Stern, S., Stewart, G., Stott, J. y John, A. (2026). Subjective and objective cognitive differences in adults in mid-life and older age with autism or high autistic traits: a systematic review and meta-analysis. Publicado 30/9/2026.
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2026.107011

[24] Pardo-Palenzuela, N., Onandia-Hinchado, I. y Diaz-Orueta, U. (2026; en línea 2025). Cognitive Profile of ADHD in Older Adults: A Systematic Review. Journal of Attention Disorders, 30(1), 152-162.
https://doi.org/10.1177/10870547251385758

[25] Dobrosavljevic, M., Solares, C., Cortese, S., Andershed, H. y Larsson, H. (2020). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in older adults: A systematic review and meta-analysis.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32798966/

[26] Norbury, C. F. et al. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: evidence from a population study.
https://doi.org/10.1111/jcpp.12573

[27] Gibson, J. L., Botting, N., Barker, E., Jackson, E. M., Leitão, S. y St Clair, M. C. (2026). Who are Adults with Developmental Language Disorder? Profiles from the Engage with Developmental Language Disorder Project.
https://doi.org/10.1177/23969415261461413

[28] Kalenjuk, E., Laletas, S., Subban, P. y Wilson, S. (2022). A scoping review to map research on children with dysgraphia, their carers, and educators. Australian Journal of Learning Difficulties, 27(1), 19-63.
https://doi.org/10.1080/19404158.2021.1999997

[29] Is There a Deficit in Product and Process of Handwriting in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder? A Systematic Review and Recommendations for Future Research (2024).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10813961/

[30] Psychometric Properties of Self-report Instruments Used in the Assessment of Developmental Coordination Disorder in Adults: A Systematic Review (2026).
https://doi.org/10.1007/s41252-026-00493-1